Clínica de las Américas

PATHWAY INSTITUCIONAL OPERATIVO
CÓDIGO SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO – CDLA

OBJETIVO

Estandarizar el reconocimiento precoz, activación, diagnóstico, tratamiento inicial, reevaluación y destino hospitalario de pacientes con sospecha o diagnóstico de sepsis y shock séptico.	Este Pathway busca: • Reducir mortalidad. • Disminuir retrasos terapéuticos. • Optimizar el inicio temprano de antibióticos. • Mejorar coordinación multidisciplinaria. • Priorizar pacientes críticos. • Fortalecer la seguridad del paciente. • Estandarizar la atención institucional.

CONCEPTO OPERATIVO INSTITUCIONAL

La sepsis constituye una emergencia médica tiempo-dependiente.
Todo paciente con sospecha de infección debe ser evaluado para detectar disfunción orgánica.
Todo paciente con disfunción orgánica debe ser evaluado para descartar infección.
La activación temprana del Código Sepsis busca evitar progresión a shock séptico, falla multiorgánica y muerte.

PASO 1 – DETECCIÓN TEMPRANA

TRIAJE Y SOSPECHA CLÍNICA

Todo paciente con sospecha o confirmación de infección deberá tener evaluación NEWS2.

ACTIVAR CÓDIGO SEPSIS SI EXISTE:

Sospecha de infección MÁS: **NEWS2 ≥5.**

O presencia de:

- PAM ≤65 mmHg.
- PAS ≤90 mmHg.
- Frecuencia respiratoria ≥22 rpm.
- Saturación ≤92%.
- Alteración del estado mental.
- Oliguria.
- Hipoperfusión.
- Lactato elevado.
- Tiempo de llenado capilar >3 segundos.
- Extremidades frías.
- Livedo.
- Hipotermia o hipertermia.

FACTORES DE ALTO RIESGO

- **Inmunosupresión.**
- **Quimioterapia.**
- **Cirrosis.**
- **Enfermedad hepática severa.**
- **Trasplante.**
- **Neutropenia.**
- **Uso crónico de corticoides.**
- **Paciente oncológico.**
- **Edad avanzada.**

PASO 2 – ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO SEPSIS

RESPONSABILIDADES DE ENFERMERÍA	RESPONSABILIDADES MÉDICAS
• Realizar escala NEWS2. • Identificar signos de alarma. • Priorizar atención inmediata. • Notificar inmediatamente al médico. • Iniciar monitorización. • Canalizar acceso venoso. • Coordinar toma urgente de laboratorios. • Registrar horarios críticos.	• Confirmar sospecha clínica. • Registrar diagnóstico presuntivo en TASY. • Activar paquete sepsis. • Definir foco infeccioso probable. • Solicitar estudios complementarios. • Iniciar tratamiento inmediato. • Definir necesidad de UTI. • Coordinar control de foco.

PASO 3 – BUNDLE SEPSIS PRIMERA HORA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Lactato ≤30 minutos.
- Antibiótico ≤1 hora.
- Hemocultivos antes del antibiótico cuando sea posible.
- Inicio precoz de reanimación.

MEDIDAS PRIORITARIAS

1. MEDICIÓN DE LACTATO

- Lactato arterial o venoso.
- Repetir si lactato ≥2 mmol/L.

2. CULTIVOS

- Un par de hemocultivos.
- Cultivos según foco:
  - Urocultivo.
  - Cultivo respiratorio.
  - Cultivo de heridas.
  - Líquidos biológicos.

IMPORTANTE:
Los cultivos no deben retrasar el inicio de antibióticos.

3. ANTIBIOTICOTERAPIA

Shock séptico o alta probabilidad de sepsis

- Inicio inmediato de antibióticos IV.
- Meta institucional ≤1 hora.

Sospecha posible sin shock

- Reevaluación rápida.
- Antibiótico ≤3 horas si persiste sospecha.

Consideraciones institucionales

- Seleccionar antibiótico según foco probable.
- Considerar microorganismos multirresistentes.
- Realizar desescalada posterior.

4. FLUIDOTERAPIA

- Cristaloides balanceados como primera línea.
- Administrar 30 mL/kg en pacientes con hipoperfusión o shock.
- Reevaluar constantemente respuesta clínica.

Reevaluación clínica de perfusión

- PAM.
- Frecuencia cardiaca.
- Diuresis.
- Llenado capilar.
- Temperatura periférica.
- Lactato.
- Estado mental.

5. VASOPRESORES

- Noradrenalina como primera línea.
- Objetivo:
  - PAM ≥65 mmHg.

Puede iniciarse por vía periférica segura mientras se obtiene acceso central.

Clínica de las Américas

PATHWAY INSTITUCIONAL OPERATIVO
CÓDIGO SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO – CDLA

PASO 4 – EXÁMENES DEL PAQUETE SEPSIS

LABORATORIOS INICIALES

- Hemograma.
- Plaquetas.
- Glucemia.
- Urea.
- Creatinina.
- Electrolitos.
- Bilirrubina total y directa.
- TP/INR.
- Gasometría.
- Lactato.
- PCR.
- Procalcitonina.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SEGÚN FOCO

- Radiografía.
- Ecografía.
- TAC.
- Cultivos específicos.
- Otros estudios dirigidos.

PASO 5 – EVALUACIÓN DE DISFUNCIÓN ORGÁNICA

SOFA

Diagnóstico de sepsis:

- Sospecha o confirmación de infección.
- Incremento ≥2 puntos SOFA.

SHOCK SÉPTICO

- Necesidad de vasopresores para mantener PAM ≥65 mmHg.
- Lactato ≥2 mmol/L pese a resucitación adecuada.

PASO 6 – CONTROL DE FOCO

Todo paciente debe ser evaluado precozmente para identificar necesidad de:

- Drenaje de abscesos.
- Cirugía abdominal.
- Retiro de dispositivos infectados.
- Desbridamiento.
- Manejo gineco-obstétrico.
- Manejo urológico.

META INSTITUCIONAL

- Control de foco ≤6 horas cuando corresponda.

PASO 7 – REEVALUACIÓN 3–6 HORAS

REEVALUAR

- Estado hemodinámico.
- PAM.
- Diuresis.
- Lactato seriado.
- Saturación.
- Perfusión periférica.
- Estado mental.
- Necesidad de expansión adicional.
- Necesidad de vasopresores.
- Necesidad de ventilación.
- Necesidad de UTI.

PASO 8 – DEFINICIÓN DE DESTINO

INGRESO A UTI

- Shock séptico.
- Uso de vasopresores.
- Lactato ≥4 mmol/L.
- SDRA.
- Ventilación mecánica.
- Disfunción multiorgánica.
- Hipoxemia severa.
- Deterioro progresivo.

CUIDADOS INTERMEDIOS

Pacientes con sepsis sin criterios de UTI, pero con riesgo de deterioro.

RECOMENDACIONES ADICIONALES

ANTIBIÓTICOS • Reevaluar continuamente necesidad antibiótica. • Buscar diagnósticos alternativos. • Realizar desescalada microbiológica. • No usar únicamente procalcitonina para decidir inicio. **REANIMACIÓN HEMODINÁMICA** • Cristaloides balanceados primera línea. • Considerar albúmina si recibió grandes volúmenes. • Priorizar evaluación dinámica de respuesta a fluidos.	**VENTILACIÓN** • Considerar cánula nasal de alto flujo. • Ventilación protectora en SDRA. **TERAPIAS ADICIONALES** • Corticoides IV en shock séptico refractario. • Estrategia transfusional restrictiva. • Profilaxis tromboembólica. • Insulina si glucemia ≥180 mg/dL.

INDICADORES INSTITUCIONALES • % antibióticos ≤1 hora. • % lactato ≤1 hora. • % hemocultivos antes de antibióticos. • % cumplimiento bundle primera hora. • Mortalidad por sepsis. • Tiempo activación → ingreso UTI/UCI.	**TECNOLOGÍA Y GESTIÓN CDLA** CDLA cuenta con: • Laboratorio 24/7. • Imagenología de alta complejidad. • Unidad de Terapia Intensiva. • Historia clínica electrónica TASY. • Monitoreo continuo. • Equipo multidisciplinario especializado. El pathway se ejecuta bajo principios de: • Seguridad del paciente. • Medicina basada en evidencia. • Respuesta rápida. • Gestión por indicadores. • Cultura institucional de calidad. • Mejora continua.

REFERENCIAS

1. Surviving Sepsis Campaign International Guidelines 2026.
2. Singer M et al. Sepsis-3 Definitions. JAMA 2016.
3. SCCM – Society of Critical Care Medicine.
4. ESICM – European Society of Intensive Care Medicine.
5. Hospital Israelita Albert Einstein – Protocolos institucionales.

Elaborado por:	Validado por:	Aprobado por:
María del Carmen Aguilera P.	*Fernando Molina*	*Bozorg Zonneveld*
Coordinador médico de emergencia	Infectólogo	Gerente médico
Fecha: *31-06-26*	Fecha: *00-00-00*	Fecha: *00-00-00*